

ENFERMEDAD DE KAWASAKI

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

Norma elaborada por el Servicio de Infectología del H. Notti, con la colaboración de los Servicios de Cardiología, Dermatología e Inmunología.

1- DEFINICIÓN

Es una vasculitis sistémica de origen desconocido que afecta principalmente los vasos de pequeño y mediano calibre, especialmente las arterias coronarias, con formación de aneurismas (25%) que pueden complicarse con trombosis, enfermedad cardíaca isquémica y aterosclerosis precoz. Fue descrita por Tomisaku Kawasaki en Japón en 1967.

2- FRECUENCIA

La incidencia es mayor en niños de origen asiático (120-150 casos cada 100.000 niños menores de 5 años), en la raza blanca es de 9/100.000. El 50% de los pacientes son menores de 2 años, el 80% menores de 4 años y el 85% menores de 5 años. Los niños menores de 6 meses y adolescentes son los más seriamente afectados, presentando un mayor riesgo de afectación cardiovascular. La relación varón/mujer es de 1.5/1. Menos del 2% de los casos presentan recidiva de la enfermedad.

La mortalidad es variable según diferentes países, Japón presenta los valores más bajos (0.08%). Tiene una mayor incidencia en los meses de invierno/primavera.

3- ETIOLOGÍA

Es desconocida y se plantean distintas hipótesis. Se postula una etiología infecciosa (toxinas derivadas del *Streptococo* y *Estafilococo*) que actuarían como superantígeno dando una perturbación inmunorregulatoria durante la fase aguda de la enfermedad, con activación de monocitos, macrófagos, células T helper, linfocitos B e incremento de inmunoglobulinas.

Se observa una mayor incidencia de casos de Enfermedad de Kawasaki (EK) secundarios (30%) a infecciones tanto virales (Parvovirus B19, CMV, VEB, VSR) como bacterianas (*Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycoplasma pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*, *Enterobacterias*, entre otros).

Otra hipótesis sostiene la presencia de una respuesta inmune exagerada mediada por Ig A.

4- CRITERIOS DIAGNÓSTICOS:

CRITERIO MAYOR:

- Fiebre: moderada a alta (39 – 40°C), asociada a irritabilidad. El primer día de fiebre es considerado el primer día de la enfermedad. La duración de la fiebre en ausencia de tratamiento es de 1 a 2 semanas, pero puede prolongarse a 3 ó 4 semanas. Con el tratamiento adecuado, la misma remite en 24 – 48hs.

CRITERIOS MENORES:

- Afectación ocular: hay una hiperemia conjuntival característica, más evidente en la conjuntiva bulbar que palpebral. No se acompaña de exudado. Es frecuente la presencia de uveítis anterior detectable por lámpara de hendidura.
- Cambios en los labios y cavidad oral: en los labios se manifiesta por eritema, sequedad, fisuras, sangrado espontáneo o al tacto. La lengua es aframbuesada (a diferencia de la escarlatina es siempre roja y no se observan membranas). A nivel de la boca se evidencia eritema difuso de mucosa oral y faríngea.
- Erupción cutánea: lo más frecuentes es un rash eritematoso polimorfo, máculo-papular no específico, puede ser escarlatiniforme o similar al eritema polimorfo. No presenta vesículas ni bullas. Las manifestaciones cutáneas se acentúan con la fiebre y son cambiantes. La descamación cutánea en la fase aguda se encuentra en el área perineal, efecta escroto en varones y labios mayores en niñas.
- Cambios en las extremidades: hay edema y eritema fundamentalmente en palmas y plantas, no deja godet, es doloroso durante la etapa aguda. En la etapa subaguda, se observa descamación en colgajos.

- Adenopatía cervical: de $\geq 1.5\text{cm}$, habitualmente unilateral y dolorosa. Puede acompañarse de eritema de la piel, pero no presenta fluctuación.
- Síntomas de afectación multiorgánica:
 - Digestivos: vómitos, diarrea, dolor abdominal, hidrops vesicular, ileo paralítico, hepatomegalia, ictericia, elevación de trasaminasas, etc.
 - Urinarios: piuria estéril de origen uretral, proteinuria, insuficiencia renal aguda.
 - Respiratorios: miringitis, disfonía, rinorrea, tos, infiltrados pulmonares.
 - Articulaciones: artralgias y artritis.
 - Neurológicos: pleocitosis mononuclear en el LCR, irritabilidad, parálisis facial.
 - Sangre: anemia leve, VSG elevada, plaquetopenia o hiperplaquetosis, leucocitosis, neutrofilia, aumento del Tromboxano A2 y la PCR.

5- DIAGNÓSTICO

El mismo se lleva a cabo a través de los criterios clínicos. Los mismos pueden o no presentarse en forma simultánea.

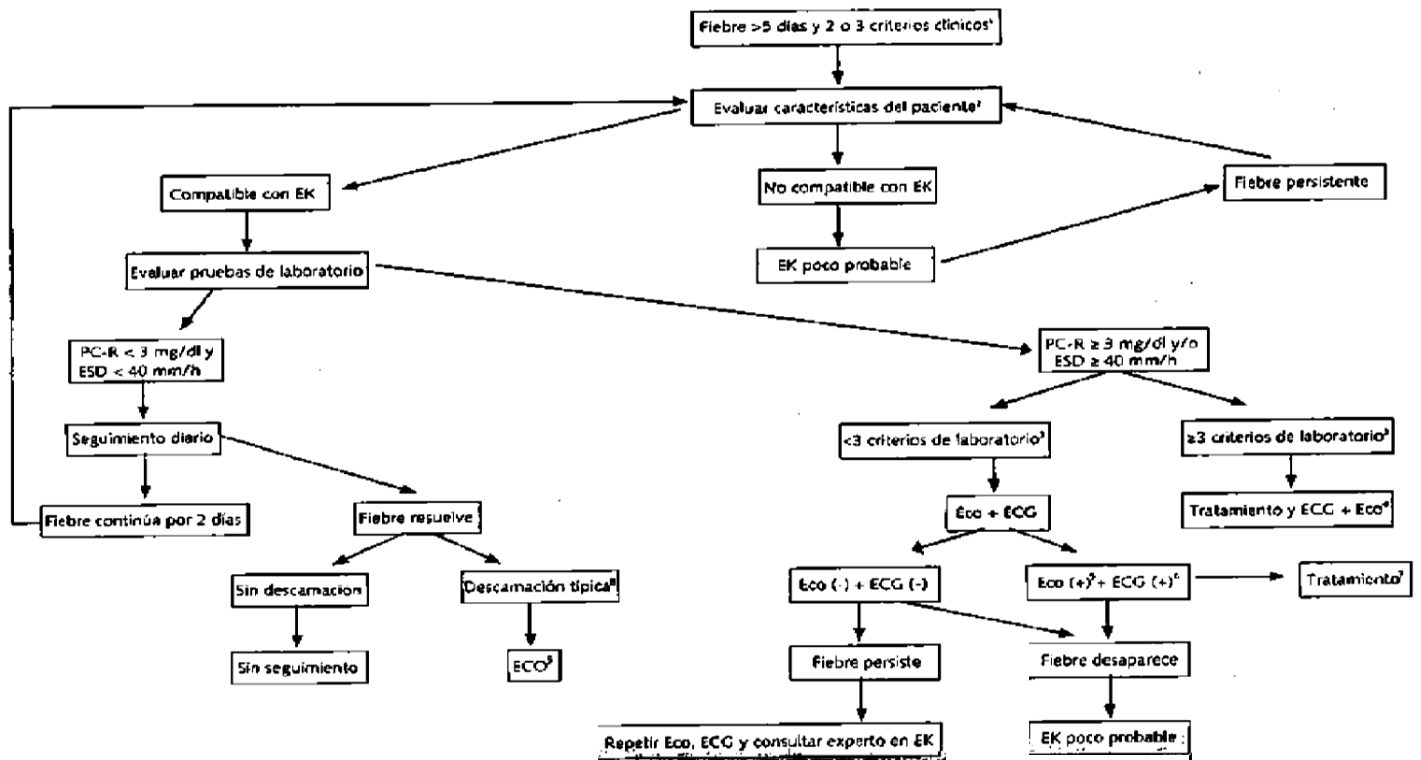
6- FORMAS CLÍNICAS

- **EK TÍPICA**: la presencia de fiebre de 5 días, más 4 de los 5 criterios menores confirman el diagnóstico.
- **EK ATÍPICA**: la presencia de fiebre de 5 días y menos de 4 criterios menores. Se estima que al menos 10% de los casos de EK son atípicos. Se han vinculado una mayor incidencia de aneurismas coronarios en pacientes con esta forma clínica, probablemente por demoras en el diagnóstico y por su evolución solapada. Existen criterios de laboratorio que contribuyen al diagnóstico de la forma atípica de la enfermedad.

7- FASES CLÍNICAS DE LA ENFERMEDAD

- Fase aguda: dura aproximadamente 10 a 14 días, se caracteriza por las manifestaciones clásicas de la enfermedad. En esta etapa se presentan la miocarditis y pericarditis.
- Fase subaguda: se extiende desde la terminación de la fiebre hasta el día 25 de evolución de la enfermedad, puede persistir irritabilidad, anorexia y la hiperemia conjuntival con descamación a nivel de los dedos de la mano y pies, además de artritis, artralgia y trombosis. Los aneurismas de las arterias coronarias se desarrollan en esta fase y el riesgo de muerte súbita es elevado.
- Fase de convalecencia: desde que desaparecen los signos clínicos hasta la normalización de los reactantes de fase aguda, lo que generalmente ocurre 6 a 8 semanas después del inicio de la enfermedad.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE KAWASAKI ATÍPICO



Todo paciente con sospecha clínica de Enfermedad de Kawasaki debe ser internado.

8- EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Laboratorio:

- Hemograma completo
- VSG - PCR
- Enzimas hepáticas (GOT, GPT, GGT)
- Bilirrubina total y fraccionada
- Albúmina
- Ionograma
- Perfil lipídico
- Ferritina
- CH50
- Orina completa

Los hallazgos de laboratorio en la etapa aguda refleja el grado de inflamación sistémica:

- Anemia
- Leucocitosis con neutrofilia y desviación izquierda
- VSG y PCR aumentadas (se normalizan en 6 a 10 semanas)
- Trombocitopenia: hacia la segunda semana (rara en la fase aguda, si aparece es un factor de riesgo coronario).
- Tansaminasas: suele encontrarse aumentada
- Hiperbilirrubinemia
- HDL disminuida
- Hipoalbuminemia: asociada a enfermedad grave
- Piuria esteril
- Toponina cardiaca I: marcadora de afectación coronaria

Estudios microbiológicos: cultivo de fauces, serología CMV, VEB, Parvovirus B19 y virológico de SNF

ECG: durante la fase aguda

Ecocardiograma doppler color: solicitar medición de puntaje Z de coronarias ($Z > 2$ se considera alteración coronaria) durante la fase aguda y a las 6-8 semanas de la misma.

9- TRATAMIENTO

- Gammaglobulina: única dosis de 2gr/kg en infusión de 12 hs. La misma reduce la incidencia de aneurismas coronarios cuando se coloca antes del día 10 de la enfermedad, pero debido a que el pico de liberación de citoquinas se produce alrededor del 6° día, la etapa más oportuna para su infusión sería entre el día 5° y 7°.

También se deberá tratar a aquellos pacientes con diagnóstico tardío (> 10 días) que persistan con fiebre o reactantes de fase aguda elevados o aneurismas coronarios.

Deberán recibir una 2° dosis de gammaglobulina aquellos pacientes que persistan febriles 48 hs posteriores a la 1° dosis (Kawasaki resistente). En caso de persistir activa la enfermedad consultar con especialistas.

- Ácido acetilsalicílico: 80 – 100 mg/kg/día VO cada 6 hs hasta 48 hs posteriores a la desaparición de la fiebre. Se reducirá la dosis a 3 – 5 mg/kg/día hasta la normalización de los reactantes de fase aguda en los casos no complicados. Los pacientes que desarrollen aneurismas deberán recibirlo hasta la desaparición de los mismos.

La utilización de anticoagulantes quedará sujeta a cada caso en particular y según criterio especialista.

10-SEGUIMIENTO

Se encontrarán en condiciones de alta aquellos que permanezcan afebriles luego de 24 hs de finalizado el tratamiento, siendo citados al consultorio de seguimiento a los 30 días con ecocardiograma, hemograma completo, VSG y PCR.

Los pacientes sin patología cardíaca o con aneurismas pequeños, finalizan su seguimiento con otro ecocardiograma entre 6 meses a un año del inicio de los síntomas.